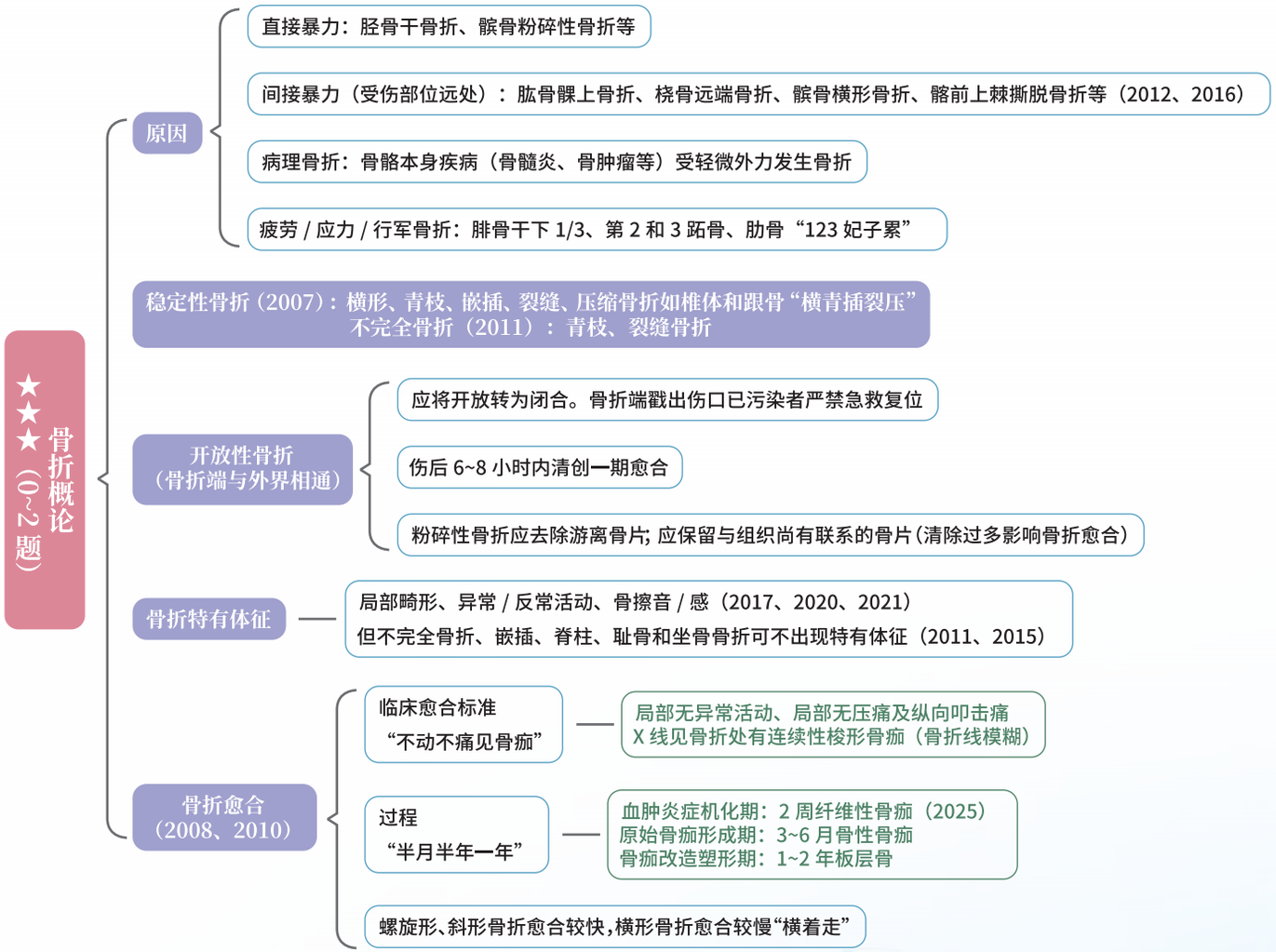

★★★骨折概论（0~2题）
原因
直接暴力：胫骨干骨折、髌骨粉碎性骨折等
间接暴力（受伤部位远处）：肱骨髁上骨折、桡骨远端骨折、髌骨横形骨折、髂前上棘撕脱骨折等（2012、2016）
病理骨折：骨骼本身疾病（骨髓炎、骨肿瘤等）受轻微外力发生骨折
疲劳 / 应力 / 行军骨折：腓骨干下 1/3、第 2 和 3 跖骨、肋骨“123 妃子累”
稳定性骨折（2007）：横形、青枝、嵌插、裂缝、压缩骨折如椎体和跟骨“横青插裂压”
不完全骨折（2011）：青枝、裂缝骨折
开放性骨折（骨折端与外界相通）
应将开放转为闭合。骨折端戳出伤口已污染者严禁急救复位
伤后 6~8 小时内清创一期愈合
粉碎性骨折应去除游离骨片；应保留与组织尚有联系的骨片（清除过多影响骨折愈合）
骨折特有体征
局部畸形、异常 / 反常活动、骨擦音 / 感（2017、2020、2021）
但不完全骨折、嵌插、脊柱、耻骨和坐骨骨折可不出现特有体征（2011、2015）
骨折愈合（2008、2010）
临床愈合标准“不动不痛见骨痂”
局部无异常活动、局部无压痛及纵向叩击痛
X 线见骨折处有连续性梭形骨痂（骨折线模糊）
过程“半月半年一年”
血肿炎症机化期：2 周纤维性骨痂（2025）
原始骨痂形成期：3~6 月骨性骨痂
骨痂改造塑形期：1~2 年板层骨
螺旋形、斜形骨折愈合较快，横形骨折愈合较慢“横着走”